

頭頸部感染手術說明書

這份說明書是有關您即將接受的手術（或醫療處置）的效益、風險及替代方案的書面說明，可做為您與醫師討論時的補充資料。最重要的是我們希望您能充份瞭解資料的內容，所以請仔細閱讀；如果經醫師說明後您還有對這個手術（或醫療處置）的任何疑問，請在簽名前再與您的醫師充分討論，醫師會很樂意為您解答，讓我們一起為了您的健康努力。

適應症及作法：（簡述）

頭頸部感染可因藥物、抗生素治療效果未改善或病情的進展，從局部擴展至組織間隙，而成為蜂窩性組織炎或膿腫的形成，嚴重時甚至會引起呼吸道阻塞、全身性感染或生命的威脅，此時以外科手術治療，可幫助病情的控制。

效益：（經由手術，您可能獲得以下的效益，但醫師並不能保證您一定能夠獲得其中的任何一項；手術效益與風險性間的取捨，應由您決定。）經由手術，您可能獲得以下所列的效益，但醫師並不能保證獲得任何一項；且手術效益與風險性間的取捨，應由您決定。經由上述手術之施行，您可能獲得以下所列部分或全部的效益 (1)降低膿腫進一步擴散或全身性感染的機會 (如腦膿瘍、眼內炎、胸縱膈腔炎、心內膜炎等) (2)加速感染的控制 (3)減少呼吸道阻塞的風險 (4)減少感染再發的機會 (5)手術處置成功率。

風險：（沒有任何手術或醫療處置是完全沒有風險的，以下所列的風險已被認定，但是可能仍然有一些醫師無法預期的風險未被列出。）沒有任何手術是完全沒有風險的，這些風險包括術中、術後可能之暫時或永久性併發症，這些併發症，嚴重時甚至可能威脅生命。以下所列的風險已被認定，但是可能仍然有一些醫師無法預期的風險未被列出。醫師將會為您解釋這些可能產生的風險及處理方式。

(一)一般性併發症

(1)傷口出血

(2)傷口疼痛

(3)傷口腫脹

(4)傷口感染或癒合不良

(5)局部或全身麻醉風險

(6)因併發症或手術效果不如預期，必要時需再度手術。

(7)必要時輸血導致之不適感或感染風險(如愛滋病、肝炎等) (如果您曾接受手術部位放射線治療、正接受或剛接受完化學治療、長期服用免疫抑制劑或抗排斥藥、或患有營養不良、血液方面疾病、糖尿病、尿毒症、肝功能異常、惡性腫瘤或其他引起抵抗病菌能力降低的疾病等，會提高術後傷口感染的機會；如果您正接受或剛接受完化學治療、長期服用抗凝血藥、或患有糖尿病、尿毒症、肝功能不良、引起血液凝固降低的疾病等，會提高出血的機會；如果您年紀超過 60 歲、嚴重貧血、患

有心肺方面疾病或功能不佳等，會提高麻醉的風險。)

(二)特殊性併發症

(1)顎骨壞死或骨髓炎

(2)術中大出血

(3)全身性感染或敗血症

(4)氣胸、呼吸困難、肺炎、肺擴張不全

(5)呼吸道阻塞導致需氣管內插管或氣管切開術

(6)顏面神經傷害導致眼睛暫時或永久性閉合不全或嘴角歪斜

(7)三叉神經傷害導致顏面、嘴唇、下頷、牙齒或舌頭暫時或永久性麻痺感。

(8)開口困難

(9)疤痕或醜型疤痕形成

替代方案：如果您決定不施行這個手術或醫療處置，可能會有危險，請與醫師討論您的決定。這個手術或醫療處置的替代方案如下：

1.不接受治療

2.持續藥物控制，視療效再決定是否手術。

3.以針筒反覆抽取膿腫 (aspiration)，取代切開引流手術(incision & drainage)。

4.保守性處置患牙 (如蛀牙填補、根管治療、牙周病治療等)

5.高壓氧治療

醫師補充說明/病人提出之疑問及解釋:(如無，請填寫無)

1.檢體作為醫學研究之用

2.手術時間

3.術後加護病房

4.呼吸方式的改變 (如氣管切開術等)

5.開口方式的改變 (如上下顎間固定等)

6.進食方式的改變 (如軟質、流質或鼻胃管進食等)

7.住院天數

8.住院費用(如健保部分負擔、健保病房費差額、自費醫材、藥物或手術項目等)

醫師已提供頭頸部感染手術說明暨同意書供病人參考，且病人對於醫師的說明均充份了解。

頭頸部感染手術同意書

一、 擬實施之手術（如醫學名詞不清楚，請加上簡要解釋）

1. 疾病名稱： 顎骨骨髓炎 顎骨壞死
2. 建議手術名稱：腐骨清除手術，34，37 移除，視情況膠原蛋白置放(自費)，若下顎骨折則施行上下顎間固定六星期
3. 建議手術原因： 緩解感染 去除病灶

二、 醫師之聲明

1. 我已經儘量以病人所能瞭解之方式，解釋這項手術之相關資訊，特別是下列事項：

☒ 需實施手術之原因、手術步驟與範圍、手術之風險及成功率、輸血之可能性。

☒ 手術併發症及可能處理方式。

☒ 不實施手術可能之後果及其他可替代之治療方式。

☒ 預期手術後，可能出現之暫時或永久症狀。

☒ 其他與手術相關說明資料，已交付病人。

2. 我已經給予病人充足時間，詢問下列有關本次手術的問題，並給予答覆：

手術風險：出血、感染、肺炎、心肺急症、呼吸道阻塞、敗血症、肺栓塞等，嚴重時可能威脅生命。其它可能手術副作用：下唇及舌暫時或長期麻木感、口腔皮膚相通、病變復發、開閉口、咀嚼、顏面感覺(麻木或疼痛)、視力或眼球運動功能暫時或永久功能障礙、開閉口疼痛、關節障礙、開口度降低、下顎 開口偏移、嘴角閉合不全漏涎、口角、唇或鄰近黏膜皮膚外傷、疤痕增生、顎骨壞死、 下顎 骨折、皮瓣壞死等風險。術後傷口癒合緩慢或不良可能需長期照顧或再手術等風險、若證實為 惡性病變， 可能需進一步手術或其他治療。術後骨壞死持續進展，未來可能需再手術之可能性。

三、 病人之聲明

1. 醫師已向我解釋，並且我已經瞭解施行這個手術的必要性、步驟、風險、成功率之相關資訊。
2. 醫師已向我解釋，並且我已經瞭解選擇其他治療方式之風險。
3. 醫師已向我解釋，並且我已經瞭解手術可能預後情況和不進行手術的風險。
4. 我瞭解這個手術必要時可能會輸血：我 ☒ 同意 ☐ 不同意輸血。

5. 針對我的情況、手術之進行、治療方式等，我能夠向醫師提出問題和疑慮，並已獲得說明。
6. 我瞭解在手術過程中，如果因治療之必要而切除器官或組織，醫院可能會將它們保留一段時間進行檢查報告或供日後研究之用，並且在之後會謹慎依法處理。
7. 我瞭解這個手術有一定的風險，無法保證一定能改善病情。

附註：

一、 手術的一般風險

1. 手術後，肺臟可能會有一小部份塌陷失去功能，以致增加胸腔感染的機率，此時可能需要
2. 抗生素和呼吸治療或其他必要的治療。
3. 除局部麻醉以外之手術，腿部可能產生血管栓塞，並伴隨疼痛和腫脹。凝結之血塊可能會
4. 分散並進入肺臟，造成致命的危險，惟此種情況並不常見。
5. 因心臟承受壓力，可能造成心臟病發作，也可能造成中風。
6. 手術過程仍可能發生難以預期的意外，甚至因而造成死亡。

二、 立同意書人非病人本人者，「與病人之關係欄」應予填載與病人之關係。

三、 手術同意書除下列情形外，應由病人親自簽名：

1. 病人為未成年人或因故無法為同意之表示時，得由法定代理人、配偶、親屬或關係人簽名。
2. 病人之關係人，係指與病人有特別密切關係之人，如伴侶(不分性別)、同居人、摯友等；或依法令或契約關係，對病人負有保護義務之人，如監護人、少年保護官、學校教職員、肇事駕駛人、軍警消防人員等。
3. 病人不識字，得以按指印代替簽名，惟應有二名見證人於指印旁簽名。

四、 醫療機構應於病人簽具手術同意書後三個月內，施行手術，逾期應重新簽具同意書，簽具手術同意書後病情發生變化者，亦同。

五、 手術進行時，如發現建議手術項目或範圍有所變更，當病人之意識於清醒狀態下，仍應予告知，並獲得同意，如病人意識不清醒或無法表達其意思者，則應由病人之法定或指定代理人、配偶、親屬或關係人代為同意。無前揭人員在場時，手術醫師為謀求病人之最大利益，得依其專業判斷為病人決定之，惟不得違反病人明示或可得推知之意思。

六、 醫療機構為病人施行手術後，如有再度為病人施行手術之必要者，仍應重新簽具同意書。

七、 醫療機構查核同意書簽具完整後，一份由醫療機構連同病歷保存，一份交由病友收執。

八、 見證人部分，如無見證人得免填載。

